外籍長照看護雇主應對指南

重點摘要

合法合規為底線：嚴格遵守工作範圍（僅限被看護者之照護與伴隨生活起居），嚴禁指派非法打掃、顧店或外借。

建立清晰工作節奏：以「每日作息時間表」取代口頭瑣碎交代，具體標註核心照護項目與明確休息時段。

尊重隱私與文化：提供獨立睡眠空間，理解宗教飲食習慣（如穆斯林不食豬肉、需禮拜），不任意扣留護照或居留證。

透明溝通與支持：利用翻譯工具降低語言障礙，建立回報機制，並給予合理休假或加班費。

聘僱家庭外籍看護（家庭看護工），雇主若能建立「專業勞雇關係」與「互相尊重」的平衡，能大幅降低磨合成本並提升長輩受照顧的品質。以下從法規邊界、工作管理、生活適應及溝通心態四個面向詳細說明：

一、 法規邊界：明確紅線，避免違法受罰

嚴守工作範圍（就業服務法第57條）

合法範圍：被看護者的日常照顧（翻身、拍背、餵食、沐浴、更衣、陪同就醫、散步）以及因照顧被看護者衍生之必要起居清潔與餐飲準備。

違法紅線：

指派打掃全家、洗全家人衣服、煮全家人三餐。

指派至雇主經營的店面、工廠幫忙（如顧攤、包裝、洗碗）。

借調給親友、鄰居幫忙照顧他人或打掃。

違者面臨新台幣3萬至15萬元罰鍰，情節重大可能被廢止聘僱許可。

證件與財物管理

移工的居留證、護照、健保卡及銀行存摺應由移工自行保管。

雇主若代為保管，需有移工本人書面同意書，且不得以扣留證件方式限制其行動自由。

休假與加班費規範

目前家庭看護工原則上依勞動契約約定每週應有1日例假。

若因被看護者照護需求協議不放假，應依法發給當日加班費（勞契約定之每日工資），不可強迫放棄休假。

二、 工作管理：系統化、作息化、SOP化

家庭看護多半非專業護理人員出身，清楚的操作流程與排程能顯著減少疏漏與誤解：

訂定「每日作息與照護時間表」

明確列出起床、量血壓、服藥、餵食、拍背翻身、復健、散步、洗澡、就寢時間。

明訂「個人休息時間」與「連續睡眠時間」，避免長達16小時以上隨傳隨到的隱形待命消耗體力。

藥物與就醫雙重查核

中文藥袋移工往往看不懂，建議由家屬分裝至日/夜藥盒，或標註早、中、晚圖示符號。

標註長輩的特殊飲食禁忌（如低鈉、糖尿病限糖、吞嚥困難需打碎或加稠化劑）。

緊急應變聯絡機制

牆上張貼重要聯絡人電話、常就醫醫院急診電話、119救護車叫車小卡（可附註地址與疾病名稱印尼文/英文對照）。

指導異常徵兆判斷標準（如發燒超過38度、血壓超過一定數值、跌倒撞擊頭部即刻通知家屬）。

三、 生活與文化尊重：創造安心的工作環境

私人空間與基本設施

提供獨立床位與個人置物空間。若需與長輩同房（便於夜間照料），應設置隔簾維持隱私。

提供衛浴設備與充足的個人生活用品，並確保冬季有保暖被褥與熱水。

宗教與飲食習慣

印尼籍看護多信仰伊斯蘭教（穆斯林）：

不吃豬肉，烹調需避免豬油或與豬肉共用鍋具。

每日需進行數次簡短禮拜，並有齋戒月（需在日出前及日落後用餐），應給予空間與理解。

菲律賓籍多信仰天主教/基督教，重視週日教會活動。

對外聯繫與心理健康

提供家中 Wi-Fi 連線，讓看護在休息時間可與家鄉親人視訊通話。移工初來台面臨思鄉與孤立，保持對外聯繫能有效穩定情緒。

避免無故限制休息時外出購買生活必需品。

四、 溝通技巧與日常相處

善用輔助工具跨越語言隔閡

初期多使用 Google 翻譯、語音即時翻譯 App 溝通重要指令。

重要照護步驟製作「圖文卡」或親自示範操作 2 至 3 次，確認理解後再放手。

正向反饋與適度界線

做對時給予口頭肯定或小點心回饋，有助於建立照護責任感。

發生失誤時，著重於「如何把事情做對」，避免辱罵、摔東西或恐嚇「送回國」，以免造成心理壓力導致隱匿長輩異常狀況。

協調長輩與看護的磨合

長輩常因依賴心態或自尊心受挫而對看護挑剔、發脾氣；家屬應擔任潤滑劑，協助向長輩解釋分工，也向看護說明長輩的脾氣與病況特點。

五、 遇到問題的處置管道

1955 勞工諮詢申訴專線：提供雙語（印尼、越南、泰國、菲律賓語）三方通話翻譯服務與法規諮詢。

委託仲介公司：若發生照護不力、失聯前兆或嚴重觀念衝突，應及早請仲介雙語輔導員介入面談協調，避免私下累積矛盾。

重點摘要

模組化分工：將看護工作拆解為「日常照護時程」、「給藥與量測」、「沐浴清潔」、「緊急應變」四大模組。

雙語與圖示化：結合中英/中印雙語對照，配合圖示與表格，確保移工清楚理解執行標準。

量化判斷標準：明確訂出數值指標（如血壓、體溫警示線）與不可逾越的安全紅線，避免主觀誤判。

針對外籍長照看護的日常工作，建議建立一套標準作業程序（SOP），張貼於長輩房內或客廳明顯處。

模組一：每日作息與例行照護排程（Daily Schedule） 時間區段 項目（中/英對照） 操作要點與注意事項
07:00 - 08:00

起床、梳洗、量測

(Morning Routine & Vitals)

• 緩慢坐起至少30秒再下床（防姿位性低血壓）

• 量測血壓、心跳、體溫並記錄於日誌

• 口腔清潔、洗臉、換尿布

08:00 - 09:00

早餐、晨間用藥

(Breakfast & Medicine)

• 坐姿至少60度進食，避免嗆咳

• 核對早藥（核對藥盒顏色/符號），服藥後喝溫水

09:30 - 11:00

復健活動、室內/戶外活動

(Rehabilitation / Walk)

• 依治療師指導進行關節活動度運動或輪椅外出散步

• 外出務必扣妥輪椅安全帶、踩煞車後再上下車

11:30 - 13:00

午餐、午藥

(Lunch & Medicine)

- 進食原則同早餐，餐後保持坐姿至少30分鐘避免胃食道逆流

13:00 - 14:30

午休時間

(Afternoon Rest)

- 長輩午睡，看護同享個人休息放鬆時間

14:30 - 15:30

水分與點心補充、翻身拍背

(Hydration & Repositioning)

• 臥床者每2小時定時翻身與減壓（背部骨突處檢查紅腫）

• 緩慢補充溫水（記錄飲水量）

16:00 - 17:30

洗澡、換洗衣物

(Bathing & Grooming)

• 浴室備妥防滑椅與防滑墊

• 先試水溫（手肘內側測試），洗完立即保暖擦乾

18:00 - 19:30

晚餐、晚藥

(Dinner & Medicine)

- 晚餐餵食與清潔，核對晚藥

20:00 - 21:30

睡前準備、就寢

(Bedtime Routine)

• 換乾淨尿布、睡前排尿、擦乳液護膚

21:30 之後

休息與夜間睡眠

(Night Rest)

- 若為高臥床翻身需求者，依約定時間夜間巡視一次（如 `02:00`）

模組二：用藥與生命徵象量測 SOP（Medicine & Vitals） 1 量測與記錄生命徵象 每日早晚各一次，記錄於紙本登記簿

體溫：正常 36.0°C - 37.4°C。

收縮壓：正常 100 - 140 mmHg。

舒張壓：正常 60 - 90 mmHg。

脈搏/心跳：正常 60 - 100 次/分。

2 核對分裝藥盒 切勿自行從散裝藥袋倒藥

雇主/家屬每週預先將藥品分裝至「早、中、晚、睡前」四格藥盒。

看護取藥時，先比對藥盒上的日期與時段標籤。

3 安全餵藥流程 進食姿勢嚴禁平躺

床頭抬高 60° 以上或協助長輩坐於椅子上。

逐顆吞服或依醫囑磨粉/以溫開水混合。

吞嚥後確認口腔內無殘留藥物，餐後維持坐姿 30 分鐘。

模組三：臥床與防跌防壓瘡 SOP（Fall & Bedsore Prevention）

防跌倒安全準則（三部曲）：

離床前「等一等」：床頭搖起坐姿 1 分鐘 → 雙腳著地垂放床緣 1 分鐘 → 無頭暈再站立。

移位「踩煞車」：輪椅停放時兩側手煞車必須鎖定，腳踏板先往上掀開，防止腳部絆倒。

視線不離身：長輩站立或如廁時，看護不可擅自離開現場。

壓瘡預防（若為長期臥床長輩）：

翻身節奏：每 2 小時變換姿勢一次（平躺 ➔ 左側躺 30° ➔ 右側躺 30°）。

減壓支撐：背部、兩膝之間夾枕頭，避免骨頭突出處相互壓迫。

皮膚觀察：每次翻身或換尿布時，檢查尾骶骨、腳後跟是否有持續性泛紅，發現紅疹或破皮立即回報。

模組四：異常狀況與緊急通報 SOP（Emergency Response）

1. 警戒數值（需當日電話/通訊軟體通知家屬）

體溫高於 38.0°C 或低於 35.5°C。

收縮壓高於 160 mmHg 或低於 90 mmHg。

連續 2 天未排便，或單日腹瀉超過 3 次。

進食量低於平時的 1/2，或出現明顯嗆咳發紺。

2. 緊急狀況處置（立即撥打 119，同步通知家屬） 1 初步安全保護 先確保長輩不受二次傷害

若跌倒：切勿急著將人拉起！先確認是否有意識、頭部有無外傷出血、肢體是否骨折畸形。

若異物哽塞/嗆咳窒息：立即拍背，若長輩意識清楚可採哈姆立克法，意識不清立即求救。

2 撥打 119 求救 報警時保持冷靜，清楚說明三件事

地址（可將家裡地址中英雙語寫於電話旁卡片）。

目前狀況（例如：「長輩跌倒撞到頭、意識不清」）。

聯絡電話與門鎖密碼/開門方式。

3 通知雇主與家屬 通報後留在長輩身邊持續觀察

依序撥打緊急聯絡人清單第一位、第二位。

備好長輩的健保卡與平日用藥清單（置於固定急救小包）。

家屬落實與推行建議

現場帶操：SOP 上牆後，家屬務必親自帶著看護演練 1-2 次（特別是量血壓、翻身轉位、輪椅收折）。

準備日誌本：提供一本簡單的橫線筆記本，劃分成「血壓/體溫」、「排便次數」、「進食水分」、「備註」，看護只需填寫數字與打勾。

翻譯備註：若看護為印尼籍，可將關鍵字翻譯為印尼文（如：Tensi=血壓, Obat=藥, Mandi=洗澡, Makan=吃飯, Minum air=喝水）。

重點摘要

照護核心轉變：中風且無意識（昏迷或極低意識）個案失去自主活動與吞嚥能力，照護重心中止「自主坐起/行走/口服藥」，全面轉為「管灌餵食」、「防吸入性肺炎」、「預防重度壓瘡（每2小時翻身）」與「關節被動運動」。

管灌安全第一：灌食前務必回抽確認胃殘餘量與位置，床頭抬高 30–45 度，灌完維持坐姿至少 30–60 分鐘，嚴禁灌食中平躺。

管路與皮膚照護：鼻胃管/導尿管須定期清潔防感染與壓痕；無意識患者極易產生壓瘡，骨突處減壓為每日死守防線。

雙語溝通關鍵：照護重點須使用印尼文/英文核心術語（如 NGT 管灌、Bedsore 壓瘡、Sedot lendir 抽痰），讓看護精準掌握指標。

針對中風且無意識（臥床、無法自主表達與吞嚥）的被照顧者，原先的活動與自行進食流程已不適用，以下為修正後的專業照護標準作業程序（SOP）：

一、 每日作息與醫療照護時程（Daily Routine）

無意識中風患者通常仰賴鼻胃管（NG tube）灌食，一般採每 3–4 小時灌食一次：

時間 項目（中/印尼文對照） 核心操作標準與注意事項 06:30 - 07:30

晨間量測、口腔與會陰清潔

(Tensi, Bersih Mulut & Kemaluan)

• 量測血壓、脈搏、體溫、血氧（Spo2）並記錄。

• 口腔海綿棒清潔：無意識者分泌物多，需防細菌滋生引發吸入性肺炎。

• 檢查尿布與尿袋尿量、顏色。

07:30 - 08:30

第 1 次管灌與鼻胃管給藥

(Sonde Makan 1 & Obat)

• 抬高床頭 30–45 度。

• 灌食前確認鼻胃管刻度並回抽胃液。

• 藥物磨粉徹底溶解後，由管路注入並以溫水 20–30ml 沖管。

09:30 - 10:30

定時翻身、被動關節運動（PROM）

(Miringkan Badan & Gerakan Sendi)

• 姿勢變換（左側躺 30 度，背部置三角墊，兩膝夾枕頭）。

• 四肢各關節被動伸展各 10–15 次，預防肌肉攣縮變形。

11:00 - 12:00

第 2 次管灌餵食

(Sonde Makan 2)

- 同灌食流程，灌食後保持床頭抬高 `30–60` 分鐘。

12:00 - 14:00

翻身（右側躺）與看護午休

(Ganti Posisi & Waktu Istirahat)

- `12:00` 進行翻身後，長輩午休，看護同步在旁休息。

14:30 - 15:30

擦澡清潔、更換衣物、床單整理

(Lap Badan / Mandi di Tempat Tidur)

• 溫水床上擦澡，特別注意腋下、腹股溝、頸部皺褶。

• 擦乾後塗抹潤膚乳液或凡士林，檢查全身皮膚有無壓紅。

15:30 - 16:30

第 3 次管灌餵食

(Sonde Makan 3)

- 灌食與給藥（如有下午藥）。

17:30 - 18:30

翻身、拍背排痰

(Tepuk Punggung & Sedot Lendir)

• 側臥姿下以手掌微凹空心拍背，由下往上、由外往內拍打。

• 若有痰音且具抽痰機，依指示進行氣管/口腔抽痰。

19:00 - 20:00

第 4 次管灌與晚藥

(Sonde Makan 4 & Obat)

- 灌食流程同上，給予夜間藥物。

20:30 - 21:30

睡前護理、翻身準備就寢

(Siap Tidur & Cek Popok)

• 更換夜用高吸收尿布，尾骶骨塗抹氧化鋅/護膚膏隔離排泄物。

• 拉起雙側床欄，調妥氣墊床功能（確認交替充氣正常運作）。

夜間 (01:00/04:00)

夜間巡視與換邊翻身

(Ganti Posisi Malam)

- 即使使用氣墊床，夜間仍建議至少每 3–4 小時輕柔協助微幅翻身減壓。

二、 鼻胃管管灌與給藥 SOP（Sonde Feeding & Medicine）

無意識患者無咳嗽反射或反射遲鈍，灌食不慎引發吸入性肺炎是致死高風險因子，必須嚴格執行以下三步驟：

1 步驟一：體位與管路查核 Persiapan & Cek Selang (嚴禁平躺灌食)

床頭搖高 30–45 度（半坐臥姿）。

確認刻度：檢查鼻胃管固定於鼻孔處的公分數刻度，若有脫出超過 2 公分切勿灌食，立即回報家屬。

回抽確認（Aspirasi）：

接空針回抽：若抽出胃液呈草綠色/淡黃色清澈，表示位置正確。

若回抽物超過 100ml 或見未消化殘渣過多，暫停本餐灌食，並將抽出的胃液回推，休息 1 小時後再評估。

若抽到鮮血或咖啡色咖啡渣樣物質，立即停止灌食並通知家屬/送醫。

2 步驟二：重力灌食與給藥 Cara Masuk Makanan (重力自流，切忌手推加壓)

灌食針筒高度維持在長輩臉部上方約 30–45 公分，利用地心引力讓配方奶自然緩慢流入（一次 250ml 約需 10–15 分鐘）。

避免空氣進入：配方液快見底時即刻倒入下一劑或溫水。

藥物管灌：所有口服藥須分開磨粉徹底溶解，先給藥後沖溫開水約 30–50ml，將管壁藥渣洗淨以防堵塞。

3 步驟三：灌後留置與觀察 Posisi Setelah Makan (預防逆流嘔吐)

灌食結束後，維持床頭抬高 30–45 度至少 45–60 分鐘。

灌食後 1 小時內嚴禁平躺、嚴禁拍背、嚴禁劇烈翻身移位。

觀察長輩是否有溢奶、臉色發紫（發紺）、劇烈喘鳴現象。

三、 壓瘡與關節攣縮預防 SOP（Bedsore & Contracture Prevention）

中風無意識患者因喪失感知與自主活動力，骨突處組織極易壞死：

每 2 小時定時翻身減壓：

採「30度側臥位」，絕不可呈90度側壓，否則大轉子骨（髖骨）會承受巨大壓力。

枕頭支撐點：

背部後方塞三角海綿枕支撐背脊。

兩膝內側、兩腳踝之間夾小枕頭（避免皮膚骨頭互相摩擦摩擦磨破）。

腳跟下方墊高懸空，不可直接壓在床面。

氣墊床日常檢查：

每日觸摸氣墊床條管是否有「一充一消」交替循環（波浪運作）。

氣壓調節需符合長輩體重，不可打到最硬（失去緩衝），也不可軟到直接接觸床底板（觸底現象 Bottoming out）。

被動關節活動（每日 2 次）：

輕柔活動肩、肘、腕、指關節，以及髖、膝、踝關節。

每個關節做曲折、伸展、內外旋轉，動作緩慢不可硬扳，遇到阻力即停，防止骨折或韌帶拉傷。

手心放置握固球或捲狀小毛巾，防手指肌肉強直痙攣屈曲。

四、 管路留置照護（鼻胃管、尿管）

鼻胃管（NG Tube）：

每天更換鼻部透氣膠帶（宜工字型或人字型固定），並輕微旋轉管子防管壁黏連潰瘍。

每日以棉花棒沾水清潔鼻腔周圍分泌物。

導尿管與尿袋（Foley Catheter）：

尿袋位置永遠低於膀胱（低於床緣），防止尿液逆流引發腎臟與泌尿道急性感染。

尿管避免扭曲、摺疊或受下肢壓迫。

尿量達尿袋的 1/2 至 2/3 時必須排空，不可放至全滿。

每日以優碘或溫水由尿道口向外單向擦拭消毒（會陰沖洗）。

五、 緊急警訊判斷與通報標準（Kondisi Darurat）

中風無意識患者無法呼痛，需仰賴細微生理徵象判斷：

異常徵兆 潛在危機 應變處置標準 血氧濃度 < 92% 或喘鳴呼吸急促 吸入性肺炎 / 呼吸道阻塞

1. 立即抬高床頭、清除口鼻分泌物或抽痰。
2. 戴上氧氣鼻導管。
3. 立即叫 119 送醫並通知家屬。

突發單側/雙側瞳孔放大或痙攣抽搐 二次中風 / 腦出血 / 癲癇發作

1. 保持側臥防口水嗆入，移開身旁硬物。
2. 不可硬塞東西入口中。
3. 立即叫 119 送醫。

體溫 > 38.2°C 伴隨畏寒發抖 肺炎、泌尿道感染或菌血症

1. 立即回報家屬。
2. 檢查尿液是否混濁/有沉澱物、痰量是否變黃稠。
3. 依醫囑準備備用退燒藥塞劑或就醫。

回抽胃液呈暗紅色、黑色咖啡渣樣 急性胃出血 / 應激性潰瘍

1. 立即停止灌食與管灌給藥。
2. 拍照留存回抽液外觀。
3. 即刻通報家屬安排送醫檢查。

尾骶骨/腳跟皮膚發黑或破皮見組織液 第 3/4 級深度壓瘡潰瘍

1. 該部位嚴禁再次受壓（架空懸空）。
2. 切勿自行亂塗牙膏、偏方藥膏。
3. 拍照回報家屬，安排長照居家護理師到府換藥清創。

請將上述中風無意識患者的「鼻胃管灌食回抽步驟」與「2小時翻身減壓技巧」，整理成繁中與印尼文對照的精簡床頭操作卡。

我將為您製作一份適合直接列印、護貝後張貼在床頭或長輩房門上的中英/印尼文雙語床頭操作卡，涵蓋「鼻胃管灌食與回抽 3 步驟」以及「2 小時翻身與擺位減壓技巧」。

這份床頭指引卡已將「鼻胃管灌食回抽 SOP」與「2小時翻身擺位減壓 SOP」整理為清楚的段落與繁中/印尼文雙語格式。建議列印成 A4 或 A3 大小並護貝，固定於長輩床邊或看護操作區域便於隨時參照。

床頭護理操作指引（繁中與印尼文對照） 床頭照護操作指引卡 / PANDUAN PERAWATAN DI SAMPING TEMPAT TIDUR

(專供中風臥床無意識個案照護使用 / Khusus Perawatan Pasien Stroke Tirah Baring)

📌 第一部分：鼻胃管灌食與回抽標準流程 BAGIAN 1: PROSEDUR PEMBERIAN MAKANAN LEWAT SELANG LAMBUNG (NGT)

⚠️ 重要原則 / PRINSIP PENTING:

嚴禁平躺灌食！ / DILARANG KERAS MEMBERI MAKAN DALAM POSISI TIDUR TERLENTANG / RATA!

步驟 1：準備與回抽確認 / Langkah 1: Persiapan & Cek Sisa Lambung (Aspirasi)

繁體中文：

將床頭搖高至 30°～45°（半坐臥姿勢）。

檢查鼻孔外的管路刻度，確認管子沒有滑脫（若滑脫超過 2cm 請勿灌食，立即通知雇主）。

用大針筒反抽胃液（回抽）：

✅ 透明/淡黃/淡綠色 且胃殘餘量 少於 100ml：正常，可將胃液緩慢推回，開始灌食。

⚠️ 胃殘餘量 大於 100ml：消化未完全，暫停本餐灌食，休息 1 小時後再抽。

🚨 抽出 黑色、咖啡渣色或鮮血：立即停止灌食！ 拍照並立刻通知雇主送醫！

Bahasa Indonesia：

Naikkan kepala tempat tidur setinggi 30° - 45° (posisi setengah duduk).

Periksa tanda garis (cm) selang NGT di dekat hidung untuk memastikan selang tidak bergeser (jika keluar > 2 cm, JANGAN beri makan, lapor majikan).

Gunakan spuit/jarum suntik besar untuk menarik cairan lambung (aspirasi):

✅ Cairan kuning muda/bening/hijau & sisa kurang dari 100ml: Normal, dorong kembali cairan secara perlahan, lalu mulai beri makan.

⚠️ Sisa makanan lebih dari 100ml: Pencernaan lambat, tunda makan selama 1 jam, lalu periksa kembali.

🚨 Cairan berwarna hitam, cokelat seperti ampas kopi, atau darah segar: SEGERA STOP! Foto cairan tersebut dan laporkan ke majikan untuk ke rumah sakit!

步驟 2：重力灌食與洗管 / Langkah 2: Proses Makan & Bilas Selang

繁體中文：

拔掉針筒活塞，管口朝上，維持高度在長輩臉部上方約 30～45 公分。

讓配方奶靠「地心引力」緩慢流入，不可用針筒活塞硬推加壓。

配方奶快流完前，立即倒入藥物（徹底磨粉攪勻）。

最後倒入 30～50 ml 溫開水 沖洗管路，避免管壁發霉或堵塞。

Bahasa Indonesia：

Lepaskan pendorong spuit, pegang tabung spuit setinggi 30 - 45 cm di atas wajah pasien.

Biarkan susu/makanan formula mengalir alami dengan gaya gravitasi, JANGAN ditekan/didorong paksa dengan pendorong spuit.

Sebelum makanan habis di tabung, masukkan obat yang sudah digerus halus dan dilarutkan.

Terakhir, bilas selang dengan air hangat sebanyak 30 - 50 ml agar selang tidak tersumbat.

步驟 3：灌後姿勢與觀察 / Langkah 3: Posisi Setelah Makan & Observasi

繁體中文：

灌食結束後，床頭維持抬高 30°～45° 至少 45～60 分鐘，預防逆流與嘔吐。

灌食後 1 小時內：嚴禁立刻平躺、嚴禁拍背、嚴禁大幅度劇烈翻身。

觀察臉色是否發紫（缺氧）或喉嚨有無咕嚕咕嚕的痰音溢出。

Bahasa Indonesia：

Setelah selesai makan, pertahankan kepala tempat tidur tetap tegak 30° - 45° minimal 45 - 60 menit untuk mencegah muntah/tersedak.

Selama 1 jam setelah makan: DILARANG telentang rata, DILARANG menepuk punggung, DILARANG membalikkan badan secara mendadak.

Perhatikan apakah wajah/bibir pucat/kebiruan atau terdengar suara dahak mengganjal.

📌 第二部分：2小時定時翻身與減壓技巧 BAGIAN 2: TEKNIK MIRING BADAN TIAP 2 JAM & MENCEGAH LUKA TEKAN (LUKA DEKUBITUS)

⏰ 翻身循環時鐘 / Jadwal Rotasi Posisi:

08:00 左側躺 ➔ 10:00 平躺 ➔ 12:00 右側躺 ➔ 14:00 平躺 ➔ 16:00 左側躺

(Kiri ➔ Terlentang ➔ Kanan ➔ Terlentang ➔ Kiri)

關鍵擺位要點 / Titik Kunci Penempatan Bantal

繁體中文：

30度側臥位，切忌90度垂直側壓：側臥過度會壓傷大腿骨外側骨頭（大轉子），造成深層壓瘡。

背部支撐：背後塞入三角枕或厚毛巾卷支撐脊椎。

兩腿之間夾枕頭：側躺時兩膝內側、腳踝之間必須夾小枕頭，避免骨頭磨擦破皮。

腳後跟懸空：腳踝下方墊薄枕頭，讓雙腳腳後跟懸空不著床面。

皮膚檢查：每次翻身時，仔細檢查尾骶骨（屁股中間骨頭）、骨盆兩側、腳後跟有無發紅或破皮。

Bahasa Indonesia：

Miring 30 derajat saja, JANGAN miring 90 derajat: Posisi miring terlalu tajam akan menekan tulang pinggul luar secara berlebih dan memicu luka dalam.

Penyangga punggung: Selipkan bantal segitiga atau gulungan handuk tebal di belakang punggung untuk menopang.

Selipkan bantal di antara kedua kaki: Saat posisi miring, letakkan bantal di antara kedua lutut dan mata kaki agar kulit dan tulang tidak bergesekan.

Tumit tidak boleh menempel: Beri ganjalan bantal kecil di bawah pergelangan kaki agar tumit kaki menggantung (tidak menekan kasur).

Pemeriksaan kulit: Setiap kali membalikkan badan, periksa area tulang ekor, pinggul, dan tumit apakah ada kemerahan atau kulit lecet.

🚨 緊急通報關鍵字與電話 / KONTAK DARURAT

| 異常狀況 / Kondisi Darurat | 立即反應 / Tindakan Cepat | | :--- | :

重點摘要

全套補齊：將中風無意識臥床個案剩餘的 4 大核心 SOP 全面轉為「繁體中文 / 印尼文（Bahasa Indonesia）」雙語對照標準卡。

涵蓋範疇：

生命徵象量測與警訊通報（Tanda Vital & Kondisi Bahaya）

每日管灌給藥與防塞管（Pemberian Obat lewat Selang）

床上擦澡、口腔清潔與會陰護理（Mandi di Tempat Tidur & Perawatan Mulut）

導尿管照護與排泄監測（Perawatan Kateter Urin & BAB/BAK）

現場導向：採用條列化、具體數值與明確警戒線，適合直接列印張貼於床邊或工作桌。

中風無意識臥床長輩日常照護 SOP（完整雙語版） PANDUAN STANDAR PERAWATAN PASIEN STROKE TIDAK SADAR (SOP LENGKAP) SOP 1：生命徵象量測與警訊通報 (SOP 1: Mengukur Tanda Vital & Tanda Bahaya) 一、每日固定量測時間 (Jadwal Pengukuran Rutin)

時間 (Waktu)：07:00（晨起）、19:00（晚間）。若有發燒或不適，每 2–4 小時加測一次。

量測項目 (Yang Diukur)：

體溫 (Suhu Tubuh / T)：正常範圍 36.0°C – 37.4°C。

血壓 (Tekanan Darah / BP)：收縮壓 100–140 mmHg / 舒張壓 60–90 mmHg。

心跳脈搏 (Denyut Nadi / HR)：每分鐘 60–100 次 (kali/menit)。

血氧濃度 (Saturasi Oksigen / SpO2)：正常需維持在 95% 以上。

二、警訊指標與處置 (Kondisi Bahaya & Tindakan Darurat) 狀況 / Gejala 數值警戒 / Batas Bahaya 處置行動 / Tindakan

發燒

Demam Tinggi

體溫 > 38.0°C

(Suhu di atas 38°C)

• 換下厚重衣物，保持通風。

• 冰枕敷額頭或頸部。

• 拍照並即時 LINE/致電通知家屬。

(Kompres dingin, laporkan ke majikan)

低血氧 / 喘

Napas Sesak / SpO2 Rendah

SpO2 < 92% 或唇色發紫

(SpO2 di bawah 92% / bibir pucat)

• 立即將床頭搖高 45 度。

• 檢查口鼻有無痰液阻塞，立即抽痰。

• 給予氧氣，狀況未改善立即叫 119 送醫。

(Naikkan kepala ranjang, bersihkan lendir, telepon 119 jika tidak membaik)

血壓極端異常

Tensi Sangat Tinggi / Rendah

收縮壓 > 160 或 < 90 mmHg

(Tensi atas >160 atau <90)

• 休息 15 分鐘後重新量測確認。

• 若持續異常，立刻通知家屬。

(Istirahat 15 menit, ukur ulang, hubungi majikan)

突發抽搐 / 意識劇變

Kejang / Pupil Beda Ukuran

身體單側抽搐、眼神偏斜

(Badan kaku, kejang-kejang)

• 絕不可塞毛巾或手指進嘴巴。

• 採側臥姿勢避免嘔吐物嗆入窒息。

• 立即撥打 119 求救並通知家屬。

(JANGAN masukkan benda ke mulut! Posisi miring, telepon 119)

SOP 2：鼻胃管給藥與防塞管 (SOP 2: Memberikan Obat Lewat Selang NGT) 1 步驟一：藥物準備與研磨 Persiapan Obat (Pisahkan & Hancurkan)

核對時段：比對早、中、晚、睡前藥盒標籤，確認長輩姓名與日期。

分開磨粉：若藥品受潮易凝固，於服藥前 10 分鐘再研磨成極細粉末。

溫水溶解：以約 20–30ml 溫開水（勿用滾燙熱水）徹底攪拌溶解，避免顆粒沉澱。

2 步驟二：床頭抬高與管路給藥 Posisi & Masuk Obat (Kepala Ranjang Naik 30-45 Derajat)

床頭搖高 30–45 度，嚴禁平躺灌藥。

灌藥針筒緩慢注入藥水，利用重力自然流入。

若有膠囊或未完全溶解顆粒，不可硬推針筒，避免塞管。

3 步驟三：溫水沖管洗淨 Bilas Air Hangat (Cegah Selang Tersumbat)

藥物注入完畢後，立即注入 30–50ml 溫開水徹底沖洗管路。

確認整條鼻胃管內壁透明無黃色/白色藥粉殘留。

灌藥後維持坐姿至少 30 分鐘，不可立刻躺平。

SOP 3：床上擦澡、口腔與皮膚照護 (SOP 3: Mandi di Tempat Tidur & Perawatan Mulut) 一、口腔海綿棒清潔 (Perawatan Mulut - Setiap Pagi & Sore)

目的：無意識長輩無法吞口水，口腔容易滋生細菌導致吸入性肺炎。

準備：口腔專用海綿棒、無酒精漱口水或溫開水。

操作：

床頭抬高 30 度，頭偏向一側。

海綿棒沾濕後「務必擰乾」（太濕會嗆到長輩喉嚨）。

輕柔擦拭牙齒外側、內側、牙齦、舌苔與上顎。

每擦完一區更換一支海綿棒，擦完後嘴唇塗抹凡士林防乾裂。

二、床上溫水擦澡 (Lap Badan / Mandi di Tempat Tidur)

水溫測試：水溫約 40°C–42°C，看護先用手肘內側試溫，確認溫熱不燙手。

順序：臉部（不加肥皂） ➔ 頸部 ➔ 雙手雙臂 ➔ 胸腹部 ➔ 雙腿 ➔ 背部與臀部。

皺褶部位重點清潔：頸部夾層、腋下、手心（扳開握拳處擦拭）、腹股溝。

皮膚檢查 (Cek Kulit)：

擦乾後全身塗抹無香精潤膚乳液。

特別檢查骨頭突出處：尾骶骨（Pantat）、腳後跟（Tumit）、髖骨兩側是否有紅斑或破皮。

SOP 4：導尿管與排泄照護 (SOP 4: Perawatan Kateter Urin & Pembuangan Air Besar/Kecil) 一、導尿管（尿袋）日常照護原則 (Aturan Selang Kencing / Kateter)

尿袋位置永遠低於腰部/床緣 (Kantong Urin Selalu di Bawah Pinggang)：

尿袋若高於膀胱，尿液會倒流回體內，引發嚴重腎臟及全身泌尿道感染。

定時排空尿液 (Kosongkan Kantong Urin)：

尿量達尿袋 1/2 至 2/3 滿時必須放水，不可等到全滿膨脹。

放尿時，開口不可碰觸髒污地板或馬桶邊緣。

每日記錄總尿量（正常成年人 24 小時尿量應在 1200ml–2000ml）。

每日會陰部清洗消毒 (Bersihkan Kemaluan Setiap Hari)：

每日洗澡時，以溫水及專用清洗液由尿道口向外單向擦拭管路約 5–10 公分。

嚴禁由外往回擦，避免將肛門周圍細菌帶回尿道。

二、尿液與排便警訊對照表 (Tanda Bahaya Kencing & BAB) 異常項目 / Gejala 觀察情況 / Kondisi 應對方法 / Tindakan

尿量驟減

Air Kencing Sedikit

連續 4 小時尿袋完全無尿

(4 jam tidak ada air kencing)

1. 檢查尿管是否被身體壓住或摺疊扭曲。
2. 輕微擠壓管路排除沉澱物阻塞。
3. 若仍無尿，立刻通知家屬。

尿液混濁/血尿

Warna Kencing Keruh / Darah

尿液呈深茶色、有白色混濁沉澱物、或鮮紅色血尿

• 拍照留存尿袋顏色。

• 通知家屬（可能泌尿道感染或結石出血）。

便秘超過 2 天

Tidak BAB 2-3 Hari

連續 2 天以上未排便，肚子摸起來硬脹

• 順時針方向輕柔按摩腹部 10 分鐘。

• 通知家屬準備依醫囑使用通便塞劑（Dulcolax）。

腹瀉

Diare (Mencret)

每日排稀水便超過 3 次

• 每次便後立即溫水洗淨臀部並吹乾。

• 塗厚層氧化鋅軟膏（Zinc Cream）隔離排泄物。

• 通知家屬，暫勿自行停灌食配方奶。

印尼文日常照護常用單字速查卡 (Kamus Ringkas Sehari-hari) 中文 (Mandarin) 印尼文 (Bahasa Indonesia) 備註說明 量血壓 Ukur Tensi / Tekanan Darah 早晚各一次 (Pagi & Sore) 量體溫 Ukur Suhu Badan / Termometer 超過 38°C 需回報 (Di atas 38°C lapor) 血氧濃度 Saturasi Oksigen (SpO2) 需維持 95% 以上 (Harus > 95%) 給藥 / 吃藥 Minum Obat / Masuk Obat 溫水沖淨管路 (Bilas air hangat) 床上擦澡 Lap Badan di Tempat Tidur 試水溫、檢查皮膚 (Cek kulit) 清潔口腔 Bersihkan Mulut 海綿棒微濕不可滴水 (Jangan terlalu basah) 倒尿袋 Buang Air Kencing 尿袋不可放高於床 (Jangan angkat tinggi) 排便 / 大便 Buang Air Besar (BAB) 記錄次數與軟硬 (Catat di buku) 抽痰 Sedot Lendir / Dahak 呼吸急促時進行 (Jika napas bunyi) 緊急打 119 Telepon 119 (Darurat) 呼吸停止、抽搐、意識驟變

長照 / 輔具代碼：長照 2.0 輔具或居家無障礙改善項目（例如氣墊床、移位機等相關代碼）？

科技 / 硬體型號：某款特定型號（例如華碩 ROG 螢幕、行動電源、耳機、相機型號）？

打字輸入法錯誤：鍵盤輸入法或拼音代碼？

重點摘要

專為列印設計：表格尺寸已配置為 A4 直式單頁滿版，字體清晰、欄位緊湊，方便每日列印一張夾在寫字板上。

繁中 / 印尼文對照：所有關鍵照護項目、時間標記與勾選項皆附印尼文（Bahasa Indonesia），外籍看護可無障礙閱讀與填寫。

四大核心模組齊全：

生命徵象量測：早/中/晚/夜間體溫、血壓、心跳、血氧（含警戒線標記）。

鼻胃管灌食與給藥：5 餐灌食量、回抽量與胃液顏色勾選、給藥標記、灌後坐姿勾選。

每 2 小時翻身拍背：日間（08:00–20:00）與夜間巡視（22:00–06:00）姿勢勾選（左/平/右）與皮膚完整度確認。

排泄與日常清潔：各時段放尿量與 24 小時總尿量計算、排便狀況、口腔清潔、床上擦澡與關節活動勾選。

表格版面預覽與使用說明

1. 基本資訊欄 (Informasi Dasar)

日期 (Tanggal)、被照顧者姓名 (Nama Pasien)、看護簽名 (Tanda Tangan Perawat)。

2. 生命徵象區 (Tanda-tanda Vital)

分為 早上 (07:00)、下午 (13:00)、晚上 (19:00)、夜間/特殊 (Malam)。

清楚標示警戒數值：發燒 >38°C 或血氧 SpO2 <92% 須即刻回報。

3. 鼻胃管灌食與給藥區 (Sonde NGT & Obat)

涵蓋每日 5 次灌食排程（07:30、11:30、15:30、19:30、23:00）。

欄位包含：回抽胃液量 (ml)、回抽顏色勾選（清/黃或深褐）、配方奶量 (ml)、溫水量 (ml)、各餐給藥打勾、灌後坐姿 45 分鐘打勾。

4. 每 2 小時翻身擺位區 (Miringkan Badan Setiap 2 Jam)

日間時段：08:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00（每格可直接勾選「左側 / 平躺 / 右側」）。

夜間巡視：22:00、00:00、02:00、04:00、06:00，右側附「尾骶骨無壓紅、腳跟懸空」皮膚確認格。

5. 尿量、排便與日常清潔護理區 (Buang Air, Kateter & Kebersihan)

尿袋放尿量：分段記錄（08:00、12:00、16:00、20:00、夜間）與全日總尿量統計。

排便狀況：排便次數、質地（成條/硬便/水瀉）、有無使用塞劑。

例行照護勾選：口腔海綿棒清潔（早/晚）、床上擦澡更衣、被動關節運動（PROM 早/下午各 15 分鐘）。

頁尾紅線警告 (Perhatian)：重申「灌食前必回抽」、「灌後坐姿 45 分鐘」、「尿袋不可高於床」三大安全原則。

登入